

30. 실신

• 중요 포인트

- 1. 실신은 자율신경/뇌/심장+기타로 나뉨.
- 2. 의식소실 여부로 실신이 아닌 것 r/o, 실신했을 때 모습으로 경련 r/o 하고 시작.
- 3. F에서는 유발 요인에 대해 물어보고, A에서는 전조증상과 계통별 문진을 진행.
- 4. 자율신경질환이라면 딱히 해야할 신체진찰이 없으므로, 기본(눈, 입) + 심장, 뇌 문제 감별을 위한 진찰을 진행.

• 평가 목표

원인				
자율신경장애			혈관미주신경실신, 기립성 저혈압, 상황성 실신, 경동맥동증후군	
뇌혈관계질환			일과성허혈발작, 뇌졸중, 척추기저동맥 부전, 쇄골하동맥 흡입증후군	
심혈관계질환			부정맥, 비대심근병증, 급성심근경색, 폐색전증, 대동맥박리	
기타			저혈당, 빈혈, 과호흡증후군, 심인성	
평가목표				
1) 병력청취와 신체진찰로 발작을 구별				
2) 실신을 유발한 원인 장기의 감별과 적절한 진단 및 치료계획 수립				
3) 응급치료가 필요한 환자를 감별				
구체적인 성과				
병력 청취	실신과 발작을 구별		경련유무: 팔다리 뻣뻣, 떨림, 혀를 깨물, 거품을 뱉, 대소변 지림 의식회복: 깨어난 후 바로 의식 회복했나 or 멍한 상태 전조증상: 쓰러지기 직전 냄새, 번쩍이는 빛	
	심장질환과 뇌질환에 의한 실신을 감별		심장질환: 쥐어짜는 흉통, 두근거림, 운동 중 실신, 심장마비나 돌연사의 가족력 뇌질환: 극심한 두통, 구토, 말 어눌, 복시, 팔다리 힘빠짐, 감각 저하	
	응급치료가 필요한 환자를 감별		심혈관 응급: 가슴통증, 호흡곤란 뇌혈관 응급: 마비, 구음 장애 저혈량성 응급: 어지러움, 두근거림, 혈변, 토혈, 구토 외상 확인	
신체 진찰	심혈관계의 이상을 확인하는 가슴진찰 등		V/S 확인: 혈압, 맥박, 호흡수 심장 청진: 불규칙한 심음, 심잡음 경동맥 청진: 잡음	
	뇌혈관질환을 확인하는 신경진찰		뇌신경검사: 동공반사, 얼굴 감각, 운동 팔다리 감각/운동/DTR 소뇌기능검사	
	이외의 원인을 감별하기 위한 신체진찰		빈혈 및 탈수 확인: 눈(결막), 구강 점막, 피부 긴장도 두부 외상 확인: 쓰러지면서 다친 곳	
진단, 치료	원인 질환	자율신경계	기립경사검사	안심, 유발 요인 회피, 생활습관 교육
		뇌혈관계/발작	뇌 MRI/MRA, 뇌파검사, 경동맥초음파	항혈소판제, 항응고제, 수술
		심혈관계	심전도, 혈액검사	약물치료, 인공심박동기, 수술
	응급치료가 필요한 질환		급성심근경색: 심근효소검사 폐색전증: D-dimer, 흉부 CT 뇌졸중: 뇌 CT, MRI 대량출혈: 위내시경, 혈액검사	기본 응급처치: ABC(기도확보, 산소투여, 수액공급) 저혈당: 포도당 정맥주사 심장성: 제세동, 심혈관중재술 저혈량성: 대량 수액공급, 수술
환자 교육	응급조치에 대해 교육		전조증상이 나타나면 앉거나 눕기 가슴통증, 말 어눌, 마비 등의 증상 발생 시 응급실 내원	

	유발요인 방지 교육	미주신경실신- 충분한 수분 섭취, 장시간 서 있는 상황 피하기 기립성 저혈압- 한번에 일어나지 말기, 유발 약물 있다면 감량 상황성실신- 대소변 볼 때 무리하게 힘주지 말기
--	------------	--

필수 임상술기: 혈압 측정

● 원인 질환 정리

질환	질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료	
자율 신경	혈관미주 신경실신 3+2	자율신경계가 과도하게 반응하면서 뇌로 가는 혈류가 부족해짐	F: 오래 서있음. 덥고 사람 많은 곳. 피를 보거나 심한 통증/스트레스 전조증상- 눈앞깜깜, 식은땀, 구역질	정상	심전도, 기립경사검사	안심시키기, 충분한 수분/염분 섭취, 대처법
	기립 저혈압 1+1	누워있거나 앉아있다가 일어설 때, 하체로 몰린 피가 뇌로 제때 올라오지 못함.	일어날 때 나타남. PMHx: 당뇨병, 전립선비대증 약, 고혈압약	기립 후 수축기 20 이완기 10 떨어짐	심전도, 기립 혈압 검사, CBC, 전해질검사	천천히 일어나기 수분 보충 원인 약물 중단
	상황성 실신	특정 상황에서 흥/복강 내 압력이 높아져 심장으로 가는 혈류 차단	배변/배뇨/기침 시 발생 음주 후 새벽에 소변보다 쓰러짐	정상	심전도, 유발 원인에 따른 검사	앉아서 소변보기, 변비 예방
심혈관 계	부정맥 1	서맥, 빈맥으로 뇌로 혈류가 제대로 가지 못함.	전조증상 없음, 자세 무관, 두근거림, 쿵 FHx: 심장마비, 돌연사	맥박, 심음 청진 이상	심전도, 24 시간 홀터 검사	서맥- 심장박동기 빈맥- 약물, 제세동기 삽입
	심근경색	심근 허혈로 심장이 피를 보내주지 못함	가슴통증, 호흡곤란	심잡음, 경정맥 확장	심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영술	관상동맥조영술, 항혈소판제, 베타차단제
	비대심근 병증/ 대동맥판 막협착	심장 구조적 문제로 운동할 때 뇌로 충분한 피를 보내주지 못함	운동중 실신 호흡곤란, 흉통	심잡음	심전도, 심초음파	약물치료(BB, CCB), 삽입형 제세동기, 수술/ 판막치환술
	대동맥 박리	혈관이 찢어지며 극심한 통증, 찢어진 혈관이 경동맥 막음, 심장을 짓누름 등	가슴통증, 등으로 방사, 고혈압, 말판중후군	양팔 혈압 다름, 맥박세기 다름, 심잡음	심전도, 흉부 X- ray, CT	혈압 강하 약물, 수술적 치료, 보존적 치료, 안정
뇌혈관 계	일과성 허혈발작 1	뇌혈관이 잠깐 막혔다가 다시 뚫린 상태	편마비, 저림, 언어장애 등이 24 시간 내 회복 PMHx: 심방세동	정상	뇌 MRI, 심전도, 심초음파	항혈소판제, 항응고제
	뇌졸중	뇌혈관이 막히거나 터져 뇌세포 손상	두통, 발열, 경부강직	신경학적증상 수막자극징후	뇌 CT/MRI/MRA 심전도, 심초음파	혈전용해제(4.5 시간), 수술, 약물(항응고, 항혈소판제)
	뇌전증	비정상적 전기 신호로 뇌 기능 멈춤. 의식 잃고 쓰러짐	전조증상(냄새, 빛 등) 팔다리 뻣뻣, 떨림, 눈 돌아감, 거품, 대소변 실신 후 멍한 상태	입(깨문 자국), 신경학적 진찰	뇌파검사, 뇌 MRI	항경련제, 뇌심부자극술
기타	빈혈	뇌에 산소 운반 부족	숨이 참, 소화기 출혈, 생리량 과다	눈(결막), 피부, 손톱	CBC, 빈혈검사, 내시경	철분제, 수혈
	저혈당	뇌로 가는 에너지 부족	PMHx: 당뇨병, 인슐린 공복, 두근거림, 식은땀		혈당검사, 전해질검사	주스, 사탕, 포도당 수액
정신	과다환기 증후군/ 공황장애	숨 빠르게 쉬어서 이산화탄소가 빠져나가 뇌 혈관 수축	실신 전 유발 상황, 호흡곤란, 입 주변 저림	호흡수	ABGA, 심전도	안심시키기, 호흡 훈련, SSRI, 인지행동치료

O	언제 당시 특별한 상황?	
L	다친 곳?	
D	지속시간 수초-실신/수분-발작 빈도	
Co	-	
Ex	이전에도? 얼마나 자주?	
C	실신 전-전조증상) 눈앞깜깜/메스꺼움/식은땀/어지럼 실신 중) - r/o 경련 - 의식 잃었나? 목격자가 있나요? - 자세 어떤 모습 (팔다리 떨림, 눈 고개 돌아감, 혀 깨물, 대소변) - 자발적 회복? 곧바로 정신을 차렸나요? 실신 후) 두통/피로/팔다리 힘빠짐	
F	환경/행동(소변/대변, 일어서기)/식사 미주신경성-오래서있기/더운환경 상황성 실신-소변/대변/기침 기립성 저혈압-일어설 때 저혈당-공복 아나필락시스-음식 앉거나 누우면 호전되는지	
A	응급) 어지러움/호흡곤란 전신) 발열/오한/체중변화/피로 저혈량) 구토/설사 +외상/ HMMH 저혈당) 공복감, 식은땀 순환기) 가슴통증/두근거림 신경) 두통/구토/말어눌/팔다리힘빠짐 정신) 실신 전 불안/숨혈떡임 불순한 뇌탈출 과다환기증후군) 실신 전 불안/숨혈떡임 순환기) 가슴통증/두근거림 뇌졸중) 두통/구토/말어눌/팔다리 힘빠짐 탈수) 구토/설사 최근 심한 출혈) HMMH	
E	건강검진	
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본 : 고혈압/당뇨/심장/뇌질환/정신	
외	수술받은 적이 있나요? 머리를 다친 적?	
약	복용중인 약물? 고혈압, 전립선약 / 이노제 / 인슐린 (용량 변화)	
사	음주/흡연/직업/스트레스/식습관/운동 수면 - 전날 잠잘랐는지	
가	비슷한 증상/심혈관/뇌혈관	
여	월경과다	
PEx	동의 구하기 손 씻기	
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 두부 외상 확인 2 눈: 빈혈, 황달 3 입: 탈수 4 목: 경동맥 청진 5 사지: 피부 긴장도, 맥박 6 흉부: 심장 청진
	신경학적 검사	[뇌신경검사] 동공반사, 안구운동, 얼굴 감각/운동

		[팔다리 운동/감각/DTR] [수막자극징후]	
추가적		소화기 의심 시 복부 시정타촉	
협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기			
혈관미주신경실신	심전도, 기립경사검사	안심, 충분한 수분/염분 섭취, 베타블록커 전조증상이 오면 쪼그려 앉거나 눕기	
기립성 저혈압	기립 혈압 측정, 심전도, CBC, 전해질검사	원인 약물 감량, 중단 일어날 때 천천히 단계적으로 일어나기	
심혈관계	심전도, 심초음파, 심근 효소 검사, 관상동맥조영술	서맥- 인공심박동기 삽입 심근경색- 관상동맥조영술 약물치료, 수술적 치료	
뇌혈관계	뇌파검사, 뇌 CT/MRI, 심전도, 심초음파, 뇌척수액검사	뇌전증- 항경련제, 뇌심부자극술 뇌졸중- 혈전용해제, 수술, 항혈소판제, 항응고제 일과성허혈발작- 항혈소판제, 항응고제	
기타	혈액검사(혈당, CBC), 심전도	저혈당- 사탕, 주스, 포도당 수액 빈혈- 철분제, 수혈 과다환기증후군- 안심, 호흡 훈련	
교육	[안심] 정확한 원인을 파악해 관리하면 조절 가능하니 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다 [응급] 두통, 팔다리 힘빠짐, 의식 떨어지는 등 신경학적 증상 발생 시 내원 주변 사람: 실신 시 수평으로 눕히고 머리는 한쪽으로 돌려 흡인 막고 기도 유지, 옷/벨트 풀기 [회피] 미주신경- 오래 서있기, 더운 환경, 공복, 스트레스 기립성- 한번에 일어나기, 저혈압 유발 약물 중단 상황성- 배뇨/배변/기침 시 무리하게 힘 주지 않기 저혈당- 공복 피하기, 당뇨약 적절하게 복용, 사탕 지참 [교정] 금주, 물 자주 마시기, 전조증상 발생 시 쪼그려 앉기, 눕기		
PPI	궁금하신 점 있으실까요?		

[궁금] 갑자기 쓰러지셔서 많이 놀라셨을 것 같습니다. 궁금하거나 걱정되시는 부분이 있나요?

[진단] 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 혈관미주신경 실신이 가장 의심됩니다. 이 질환은 자율신경 이상으로 발생하는 질환입니다. 하지만 그 외에 기립성 저혈압, 부정맥 등도 완전히 배제할 수 없습니다.

[검사/치료] 따라서 정확한 진단을 위해 기립경사검사와 심전도검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요? 만약 검사로 혈관미주신경 실신이 확진된다면 특별한 치료 없이 우선 지켜 볼 수 있습니다 이 질환은 대부분 자연적으로 호전됩니다. 하지만 지속적으로 실신이 발생할 경우 약물 치료가 필요할 수 있습니다

[교육] 덩거나 사람이 많은 곳에 오랫동안 서 있어야 하는 상황, 과도하게 긴장하는 상황 등 스트레스를 받는 상황을 회피하시는게 좋습니다. 또한 어지러울 경우 몸을 낮춰 머리를 보호하고, 여의치 않다면 주먹을 꼭 쥐거나 다리를 꼬아 힘을 주십시오. 주변사람들에게는 __님이 실신할 가능성이 있다는 걸 알리고, 실신했을 때 당황하지 말고 셔츠 단추와 허리띠를 풀어 정신을 차릴 때까지 혈액순환만 원활이 해달라고 부탁해 두십시오.

마지막으로 궁금한 점 있으실까요?

+ 질환 설명

미주신경성 실신: "오래 서 계시거나 스트레스를 받을 때 몸의 신경이 일시적으로 오작동을 해서 혈압이 떨어지고 뇌로 가는 피가 부족해져서 어지럽고 쓰러지신 겁니다. 큰 병이 있는 건 아니니 너무 걱정하지 마세요."

기립성 저혈압: "누워 있거나 앉아 계시다가 갑자기 일어날 때, 다리 쪽에 있던 피가 심장과 뇌로 빨리 올라오지 못해서 순간적으로 쓰러지게 되신 겁니다."

상황성 실신: "소변이나 대변을 보실 때, 또는 기침을 심하게 하실 때 배에 갑자기 힘이 들어가면서 심장으로 돌아가는 피의 양이 일시적으로 줄어들어 기절하시게 된 겁니다."

부정맥: "심장의 전기 신호에 문제가 생겨서 맥박이 불규칙해지다 보니, 뇌로 피를 제대로 뿜어주지 못해 갑자기 쓰러지신 상태입니다."

비대심근병증 (HCM): "유전적으로 심장 안쪽 근육이 좀 두꺼워져 있으신데요, 평소엔 괜찮다가 운동을 하실 때 이 근육이 피가 나가는 길을 좁게 만들어서 뇌로 피가 덜 가 기절하신 겁니다."

"대동맥박리: "심장에서 나오는 가장 큰 혈관인 대동맥의 안쪽 벽이 찢어지면서 극심한 통증이 오고 뇌로 가는 혈류에 문제가 생겨 쓰러지신 응급 상황입니다. 혈관이 더 찢어지지 않게 바로 조치를 취해야 합니다."

심근경색: "심장 근육에 피를 공급하는 혈관이 피떡으로 갑자기 꽉 막혀서 가슴이 심하게 아프고, 심장 펌프 기능이 떨어지면서 쓰러지시게 된 겁니다. 막힌 혈관을 뚫어주는 시술이 시급합니다."

빈혈: "피 속에서 산소를 나르는 적혈구가 부족해져서, 몸을 움직이실 때 뇌로 가는 산소가 모자라 어지럽고 쓰러지게 되신 겁니다."

과다환기증후군: "너무 불안하거나 스트레스를 받으셔서 본인도 모르게 숨을 가쁘게 쉬시다 보니, 몸속 이산화탄소가 과하게 빠져나가 뇌혈관이 수축하면서 어지럽고 손발이 뻣뻣하게 저리게 되신 겁니다."

저혈당: "식사를 거르시거나 당뇨약 효과가 평소보다 강하게 나타나서, 뇌가 써야 할 에너지원인 혈당이 뚝 떨어지는 바람에 뇌가 일시적으로 작동을 멈추고 쓰러지시게 된 겁니다."

일과성 허혈 발작 (TIA): "뇌로 가는 혈관이 피떡 때문에 아주 잠깐 막혔다가 다시 뚫리면서 일시적으로 쓰러지셨던 겁니다."

뇌졸중 (뇌경색/뇌출혈): "뇌혈관이 막히거나 터져서 뇌세포가 손상을 입어 쓰러지신 상태입니다. 마비 같은 후유증을 최소화하기 위해 지금 당장 막힌 혈관을 뚫는 응급 치료를 시작해야 합니다."

뇌전증 (발작): "뇌의 신경세포들이 일시적으로 비정상적인 전기를 과하게 내뿜으면서, 뇌 기능이 잠시 멈추고 사지에 경련을 일으키며 쓰러지신 겁니다."